# 在宅看取り場所一致率 ― 全スタッフ向けスライド（ 20分）

参考文献

2026-03-30 · AI（Claude）作成・主な出典は原典で確認

# 最期の場所が「希望通り」であること
# ― 患者さんとご家族にとっての意味

- 「自分で選んだ場所で最期を迎えられた」という安心感
- ご家族にとっては「約束を守れた」という心の支え
- 反対に、希望と違う場所での看取りは、遺族の後悔につながることがある

*問いかけ:「あなたが関わった患者さん・利用者さんは、希望通りの場所で最期を迎えられましたか？」*

# 今日の学習目標

1. **トランジション（場の移行）における自分の職種の役割**　を説明できる
2. **家族支援の具体的アプローチ** を3つ挙げられる
3. **急変時の連携フロー** を知り、自分がとるべき行動を理解する

*すべての職種に関係するテーマです。「私には関係ない」ではなく、「私にもできることがある」を見つけましょう*

# ACP（アドバンス・ケア・プランニング）とは？

- **一言でいうと**：「これからのことを、本人・ご家族・私たちで一緒に話し合い続けること」
- 一度決めたら終わりではなく、状況が変わるたびに何度でも話し合う
- 「人生会議」という愛称でも知られている
- 紙に書くことより、**対話のプロセスそのもの** が大切

  *大切なポイント: 患者さんの気持ちは変わることがある。だからこそ「繰り返し」が重要*

# 研究が教えてくれたこと（数字を身近に）

**緩和ケア病棟から自宅に退院した患者さん359人の遺族調査（2018年）**

- **自宅で亡くなった方**：100人いたら**80人**は、事前の方針通りの場所で最期を迎えられた
- **緩和ケア病棟で亡くなった方**：100人いたら**82人**は、方針通り

**でも裏を返すと…**

- **100人のうち約20人**は、方針と違う場所で亡くなっている
- しかもこれは、緩和ケア病棟を経験した、**専門的な支援を受けた方たち** の数字

*海外の研究では、一致率は21%～100%と研究ごとに大きく違います（定義や対象が異なるため、単純な比較はできません）。この数字が示すように、改善の余地はまだあります*

# 不一致が起きる理由

### 自宅での看取りが叶わなかった主な理由

- **痛みの管理が難しかった** ― 在宅では24時間の対応が難しい場面がある
- **在宅で対応できる医師がいなかった** ― 地域によって医師の数に大きな差がある
- **ご家族の介護負担が限界を超えた** ―「見ていられない」という心理的つらさも

### 逆に「病棟の予定だったけど自宅で看取れた」ケースも

- 在宅医療に対応してくれる医師・看護師が見つかった（ポジティブな変化）

# あなたの職種でできること（ 1）

## 看護師

- 退院前カンファレンスでの情報引き継ぎ
- 症状変化の早期発見と医師への報告
- ご家族への症状管理の教育（レスキュー薬の使い方など）

## ソーシャルワーカー（SW）/ 医療相談員

- 在宅サービスの調整（訪問診療、訪問看護、介護保険）
- ご家族の経済的・社会的不安への対応
- バックアップベッド（急変時の再入院先）の事前確保

## ケアマネジャー

- 介護サービスの迅速な調整
- ご家族のレスパイト（休息）支援の計画
- 在宅チーム全体の連携の要

# あなたの職種でできること（ 2）

### 薬剤師

- レスキュー薬（痛み止め）の事前配置と使い方の説明
- 服薬管理のサポート
- 医師との薬剤調整の橋渡し

### 介護職

- 日々のケアの中での「いつもと違う」の気づき
- 学会員への調査では、介護従事者向けの地域教育活動を行っているという回答は約1割にとどまった
- **あなたの「気づき」が、医療チームへの大切な情報になる**

*現実の課題: 介護職向けの緩和ケアの教育活動は、まだ十分に広がっていない*

まとめ

# ご家族への声かけ ― 明日から使える3つのアプローチ

### 1. 不安を受け止める声かけ

- 「夜、ひとりで見ているのは不安ですよね。何かあったらいつでも連絡してください」
- 「がんばりすぎていませんか？あなたの体も大切です」

### 2. 急変時に備える声かけ

- 「もし急に痛みが強くなったら、まずこのお薬を使ってください。そのあと○○に電話してください」
- 「夜間の連絡先はここに貼っておきますね」

### 3. 看取りに向けた心の準備の声かけ

- 「ご本人の希望を、改めて確認しておきましょうか」
- 「今のお気持ちを聞かせていただけますか？何でも大丈夫ですよ」

# グループワーク（ 5分）「自分の職種でできること」

## お題

隣の人と話し合ってください:

> *「緩和ケア病棟から自宅に戻った患者さんが、希望通りの場所で最期を迎えるために、**あなたの職種で**できることは何ですか？」*

## 考えるヒント

- 退院前にできること
- 退院直後にできること
- 在宅療養中にできること
- 急変時にできること

*正解はありません。「自分ならこうする」を考えてみてください*

# 今日から始める、あなたのアクション

## 職種別の「まず 1つ」

| 職種 | 明日からの 1アクション |
| --- | --- |
| 看護師 | 退院前カンファレンスで「急変時の連絡先」を必ず確認する |
| 介護職 | 「いつもと違う」を感じたら、その日のうちに看護師に伝える |
| SW/相談員 | バックアップベッドの確保状況を退院前にチェックする |
| ケアマネ | 家族のレスパイトニーズを月1回は確認する |
| 薬剤師 | レスキュー薬の配置と使い方を家族に説明する |

# 今日から始める、あなたのアクション（続き）

## 参考資料


- 佐藤桃香ほか. Palliative Care Research 2026;21(1):31-39
- 川島有沙ほか. Palliative Care Research 2026;21(1):69-73
- 日本版ACP定義: acp-japan.org


*「自分には関係ない」→「自分にもできることがある」*